



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN PENGKAJIAN PASIEN
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 552.170/I-PND/DIR/VI/2025

Tentang
Panduan Pengkajian Pasien

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB PP



(Wiwit Indah Yanti, S.Kep.,Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini M. Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Pengkajian Pasien dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Panduan Pengkajian Pasien yang dipergunakan pada tahun 2026 meliputi asesmen awal dan asesmen ulang yang dilaksanakan oleh PPA.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Pengkajian Pasien ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 01 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP.,CCht.,CI.,CHEA.,CHQP

Penyusun:

1. Puput Sekar Nariratih, AMd. Keb
2. Ns. Wiwit Indah Yanti, S. Kep
3. Ns. Very Susanto, S. Kep
4. Wahyuni, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
PERATURAN DIREKTUR	v
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Maksud dan Tujuan	11
BAB II RUANG LINGKUP	12
3.1 Ruang Lingkup Panduan Pengkajian Pasien	12
BAB III TATA LAKSANA	13
4.1 Jenis-jenis Pengkajian Pasien	13
4.2 Data dan Informasi Isi Pengkajian Pasien	14
4.3 Analisis Data Hasil Informasi Isi Pengkajian Pasien	15
4.4 Pelaksanaan Rencana Asuhan/Perawatan	16
BAB IV PENUTUP	18

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 552.170/I-PND/DIR/VI/2025**

**TENTANG
PANDUAN PENGKAJIAN PASIEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Rekam Medis dengan Peraturan Direktur tentang Panduan Pengkajian Pasien;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur 552.170/I-PND/DIR/VI/2025 tentang Panduan Pengkajian Pasien;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PANDUAN PENGKAJIAN PASIEN**

Pasal 1

- (1) Rumah sakit menentukan isi, jumlah, dan jenis pengkajian awal pada disiplin medis dan keperawatan.
- (2) Isi minimal pengkajian awal antara lain :
- a) keluhan saat ini,
 - b) status fisik;
 - c) psiko-sosio-spiritual;
 - d) ekonomi;
 - e) riwayat kesehatan pasien;
 - f) riwayat alergi;
 - g) pengkajian nyeri;
 - h) risiko jatuh;
 - i) pengkajian fungsional;
 - j) risiko nutrisi;

- k) kebutuhan edukasi;
 - l) sasaran;
 - m) Perencanaan Pemulangan Pasien (*Discharge Planning*).
- (3) Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis pengkajian awal disiplin medis.
 - (4) Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis pengkajian awal disiplin keperawatan.
 - (5) Ada bukti keterlibatan keluarga dalam melengkapi pengkajian awal.

Pasal 2

- (1) Pengkajian awal medis dan keperawatan dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenang klinis yang ditetapkan.
- (2) Pengkajian awal medis menghasilkan diagnosis medis yang mencakup kondisi utama dan kondisi lainnya yang membutuhkan tata laksana dan pemantauan
- (3) Pengkajian medis yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur di rawat jalan, harus dilakukan waktu atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, jika lebih 30 (tiga puluh) hari, akan dilakukan pengkajian ulang
- (4) Pengkajian awal keperawatan menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi atau pemantauan pasien yang spesifik.
- (5) Sebelum pembedahan pada kondisi mendesak, minimal terdapat catatan singkat dan diagnosis praoperasi yang didokumentasikan di dalam rekam medik

Pasal 3

- (1) Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sebagai pengkajian tambahan.
- (2) Penerimaan nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik tercatat di dalam rekam medis.
- (3) Alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien tercatat di dalam rekam medis.
- (4) Proses perencanaan pemulangan pasien yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus dan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut disusun sejak pengkajian awal dan pelaksanaannya dicatat di rekam medis
- (5) Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam rekam medis dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisi yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang.
- (2) Pasien diskriminasi untuk risiko nutrisi sebagai bagian dari pengkajian awal
- (3) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, produk darah, pengambilan spesimen, dan pemberian diet.

-
- (4) Pasien dengan risiko nutrisi dilanjutkan dengan pengkajian gizi.

Pasal 5

- (1) Rumah sakit menetapkan kriteria pengkajian kebutuhan fungsional dan risiko jatuh, yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang.
- (2) Pasien diskriminasi untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh.
Pasien dengan kebutuhan fungsional lanjutan termasuk risiko jatuh, memperoleh asuhan yang sesuai ketentuan rumah sakit

Pasal 6

- (1) Ada regulasi yang mengatur tentang mencegah pasien cedera karena jatuh.
- (2) Rumah sakit melaksanakan suatu proses pengkajian terhadap semua pasien rawat inap dan rawat jalan dengan kondisi, diagnosis, dan lokasi teridentifikasi berisiko tinggi jatuh sesuai dengan regulasi.
- (3) Rumah sakit melaksanakan proses pengkajian awal, pengkajian lanjutan, pengkajian ulang dari pasien rawat inap yang berdasar atas catatan teridentifikasi risiko jatuh.
Langkah-langkah diadakan untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien dari situasi dan lokasi yang menyebabkan pasien jatuh

Pasal 7

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi pasien diskriminasi untuk rasa nyeri.
- (2) Apabila diidentifikasi ada rasa nyeri pada pengkajian awal, lakukan pengkajian lebih mendalam, sesuai dengan umur pasien, dan pengukuran intensitas dan kualitas nyeri seperti karakter, kekekalan/frekuensi, lokasi dan lamanya.
- (3) Pengkajian dicatat sedemikian sehingga memfasilitasi pengkajian lanjutan yang teratur dan tindak lanjut sesuai kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan kebutuhan pasien.

Pasal 8

- (1) Pengkajian awal rawat inap harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap;
- (2) Pengkajian awal rawat jalan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 jam setelah dilakukan pengkajian;
- (3) Pengkajian gawat darurat harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dilakukan asuhan sesuai kebutuhan pasien.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengkajian tambahan untuk populasi pasien tertentu.
- (2) Pengkajian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain untuk:
 - a) Neonatus
 - b) Anak

- c) Remaja
- d) Obstetri/maternitas
- e) Geriatri
- f) Sakit terminal/menghadapi kematian
- g) Pasien dengan rasa sakit kronik atau nyeri (intense)
- h) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatri
- i) Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol
- j) Korban kekerasan atau kesewenangan
- k) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius
- l) Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi
- m) Pasien dengan sistem imunologi terganggu

- (3) Terhadap populasi pasien tersebut dilaksanakan pengkajian tambahan sesuai regulasi rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Ada regulasi tentang pengkajian ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya untuk evaluasi respons pasien terhadap asuhan yang diberikan sebagai tindak lanjut.
- (2) Ada bukti pelaksanaan pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut.
- (3) Ada bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien.
- (4) Ada bukti pengkajian ulang oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Pengkajian ulang medis dan keperawatan dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenang klinis yang ditetapkan;
- (2) Pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut;
- (3) Pengkajian ulang perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien;
- (4) Pengkajian ulang oleh profesional pemberi asuhan lainnya dilaksanakan sesuai kondisi pasien.

Pasal 12

- (1) Ada regulasi asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap.
- (2) Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat oleh PPA yang memberikan asuhan di rekam medis pasien.
- (3) Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data pengkajian awal dan kebutuhan pasien.
- (4) Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien, dimutakhirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas pengkajian ulang.
- (5) Perkembangan pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi

pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP

- (6) Pencatatan pada CPPT setiap hari terdapat penulisan DPJP minimal satu kali/hari, Perawat tiap shift, Gizi dan apoteker sesuai dengan kebutuhan pasien
- (7) Apabila pasien ada rawat bersama, diantaranya adalah DPJP utama dan DPJP konsulan.

Pasal 13

- (1) Ada regulasi tentang tindakan klinis dan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis.
- (2) Staf yang meminta beserta apa alasan dilakukan tindakan dicatat di rekam medis pasien.
- (3) Hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien.
- (4) Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 01 Oktober 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 552.170/I-PND/DIR/VI/2025
TENTANG
PANDUAN PENGKAJIAN PASIEN

PANDUAN PENGKAJIAN PASIEN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Tujuan dari pengkajian adalah untuk menentukan perawatan, pengobatan dan pelayanan yg akan memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien. Proses pengkajian pasien yg efektif akan menentukan keputusan mengenai kebutuhan pengobatan pasien untuk keadaan GD, elektif, atau perawatan yg terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah. Pengkajian pasien merupakan proses yg berkelanjutan dan dinamis yg berlangsung di unit rajal, unit ranap, departemen, dan klinik. Pengkajian pasien terdiri atas IAR :

- a) Mengumpulkan informasi dan data terkait keadaan fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat kesehatan pasien. → I
- b) Menganalisis data dan informasi, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, pencitraan diagnostik, dan pemantauan fisiologis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien akan layanan kesehatan. → A
- c) Membuat rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien yg telah teridentifikasi. → R

Pengkajian pasien yg efektif akan menghasilkan keputusan tentang kebutuhan asuhan, pengobatan pasien yg harus segera dilakukan dan pengobatan berkelanjutan untuk emergensi, elektif atau pelayanan terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah.

Asuhan pasien di RS diberikan dan dilaksanakan berdasarkan konsep pelayanan berfokus pd pasien (*Patient/Person Centered Care*) Pola ini dipayungi oleh konsep WHO dalam *Conceptual framework integrated peoplecentred health services*. Penerapan konsep pelayanan berfokus pd pasien adalah dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yg bersifat integrasi horizontal dan vertikal dengan elemen :

1. Dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan / clinical leader
2. Profesional pemberi asuhan (PPA) bekerja sebagai tim intra dan inert disiplin dengan kolaborasi inter professional dibantu antara lain dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya, Alur Klinis / *Clinical Pathway* terintegrasi
3. Manajer Pelayanan Pasien / *Case Manajer*
4. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga

Pengkajian ulang harus dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan untuk megidentifikasi kebutuhan pasien. Pengkajian ulang adalah penting untuk memahami respons pasien terhadap pemberi asuhan, pengobatan dan pelayanan, serta penting juga untuk menentukan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif. Proses – proses ini paling efektif jika dilaksanakan bila berbagai professional kesehatan yang bertanggungjawab dan bekerjasama.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Proses pengkajian pasien digunakan untuk menentukan perawatan, pengobatan, dan pelayanan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien

1.2.2 TUJUAN

A. Tujuan Umum

Untuk mengetahui proses pengkajian dalam menentukan perawatan, pengobatan, dan pelayanan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien

B. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui jenis-jenis pengkajian pasien
- b. Untuk mengumpulkan informasi dan data terkait keadaan fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat kesehatan pasien
- c. Untuk menganalisis data dan informasi termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, pencitraan diagnostik dan pemantauan fisiologis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien akan layanan kesehatan
- d. Untuk membuat rencana perawatan dalam memenuhi kebutuhan pasien yang telah terintegrasi

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam panduan pengkajian pasien meliputi :

- a. Jenis-jenis pengkajian pasien
- b. Data dan informasi isi pengkajian pasien
- c. Analisis data hasil informasi isi pengkajian pasien
- d. Rencana perawatan

Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pengkajian pasien meliputi :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam MediS

BAB III TATA LAKSANA

A. Jenis-jenis pengkajian pasien

Pengkajian pasien yg efektif akan menghasilkan keputusan tentang kebutuhan asuhan, pengobatan pasien yg harus segera dilakukan dan pengobatan berkelanjutan untuk emergensi, elektif atau pelayanan terencana, bahkan ketika kondisi pasien berubah. Asuhan pasien di RS diberikan dan dilaksanakan berdasarkan konsep pelayanan berfokus pd pasien (Patient/Person Centered Care) Pola ini dipayungi oleh konsep WHO dalam Conceptual framework integrated peoplecentred health services. Penerapan konsep pelayanan berfokus pd pasien adalah dalam bentuk Asuhan Pasien Terintegrasi yg bersifat integrasi horizontal dan vertikal dengan elemen sebagai berikut :

1. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sebagai ketua tim asuhan/*Clinical Leader*.
2. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional, dibantu a.l. dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), Panduan Asuhan PPA lainnya, Alur Klinis/*Clinical Pathway* terintegrasi, Algoritma, Protokol, Prosedur, Standing Order dan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi).
3. Manajer Pelayanan Pasien/Case Manager.
4. Keterlibatan dan pemberdayaan pasien dan keluarga.

Pengkajian ulang harus dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Pengkajian ulang adalah penting untuk memahami respons pasien terhadap pemberian asuhan, pengobatan dan pelayanan, serta juga penting untuk menentukan apaakah keputusan asuhan memadai dan efektif. Proses2 ini paling efektif dilaksanakan bila berbagai profesional kesehatan yg bertanggung jawab atas pasien bekerja sama

Standar Pengkajian yang berfokus kepada pasien terdiri dari :

1. Pengkajian awal;
 1. Identitas pasien
 2. Keluhan pasien
 3. Riwayat kesehatan
 4. Pemeriksaan fisik
 5. Pengkajian Nyeri
 6. Pengkajian resiko
 7. Aspek Psikososial dan spiritual

2. Pengkajian ulang;

Pengkajian ulang didokumentasikan di CPPT. Pengkajian ulang dilakukan oleh tenaga medis dan perawat minimal satu kali. Untuk perawat dilakukan setiap shift, untuk PPA lain sesuai dengan kebutuhan pasien. Proses pengkajian yang dilakukan oleh PPA menggunakan metode S-O-A-P.

- **S (SUBJECTIVE)** atau Subyektif adalah keluhan pasien saat ini yang didapatkan dari anamnesa (autoanamnesa atau aloanamnesa).
- **O (OBJECTIVE)** atau Objektif adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini.
- **A (ASSESSMENT)** atau penilaian keadaan adalah berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien, yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subyektif dan obyektif.

-
- **P (PLAN)** atau rencana asuhan adalah berisi rencana untuk menegakan diagnosis (pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasti), rencana terapi (tindakan, diet, obat-obat yang akan diberikan), rencana monitoring (tindakan monitoring yang akan dilakukan, misalnya pengukuran tensi, nadi, suhu, pengukuran keseimbangan cairan, pengukuran skala nyeri) dan rencana pendidikan (misalnya apa yang harus dilakukan, makanan apa yang boleh dan tidak, bagaimana posisi dan sebagainya).

3. Pelayanan laboratorium dan pelayanan darah; dan
4. Pelayanan radiologi klinik

B. Isi minimal pengkajian pasien

Isi minimal pengkajian pasien meliputi :

- a. Keluhan saat ini
- b. Status fisik;
- c. Psiko-sosio-spiritual;
- d. Ekonomi;
- e. Riwayat kesehatan pasien;
- f. Riwayat alergi;
- g. Riwayat penggunaan obat;
- h. Pengkajian nyeri;
- i. Risiko jatuh;
- j. Pengkajian fungsional;
- k. Risiko nutrisi;
- l. Kebutuhan edukasi;
- m. Perencanaan pemulangan pasien (Discharge Planning)

Proses pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan dilakukan di IGD, Rawat inap dan rawat jalan. Hasil Analisa yang diperoleh dari informasi yang meliputi data terkait keadaan fisik, psikologis, status sosial, dan Riwayat Kesehatan pasien menghasilkan suatu diagnosis / masalah keperawatan dan masalah medis.

Rencana asuhan atau perawatan pasien meliputi rencana tindak lanjut pengobatan, antara lain rawat jalan, rawat inap, rujuk dan pengobatan maupun dalam keadaan meninggal.

Pengkajian tambahan untuk pasien tertentu atau untuk populasi pasien khusus mengharuskan proses pengkajian tambahan sesuai dengan kebutuhan populasi pasien tertentu. Setiap RS menentukan kelompok populasi pasien khusus dan menyesuaikan proses pengkajian untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Populasi khusus diantaranya sebagai berikut :

- a) Neonatus
- b) Anak.
- c) Remaja
- d) Obstetri / maternitas
- e) Geriatri
- f) Sakit terminal / menghadapi kematian
- g) Pasien dengan nyeri kronik atau nyeri (intense)
- h) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatri.
- i) Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol.
- j) Korban kekerasan atau kesewenangan.
- k) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius.
- l) Pasien yg menerima kemoterapi atau terapi radiasi.
- m) Pasien dengan sistem imunologi terganggu.

Tambahan pengkajian terhadap pasien ini memperhatikan kebutuhan dan kondisi mereka berdasarkan budaya dan nilai pasien. Proses pengkajian awal dan ulang

dilakukan oleh seluruh PPA yang meliputi : tenaga medis, tenaga keperawatan , tenaga kebidanan, apoteker, gizi, dan fisioterapi dan rekam medis.

Proses pengkajian pasien awal rawat inap harus dilakukan oleh seluruh PPA dalam waktu 1x24 jam. Jika pengkajian awal pasien di rajal dengan suatu diagnosis “X”, bila pasien berulang / kambuh dengan penyakit “X” dan datang kurang dari /sama dengan 30 hari, maka dilakukan pengkajian ulang. Pengkajian awal pasien di rajal dengan suatu diagnosis “X”, bila pasien berulang / kambuh dengan penyakit “X” dan datang lebih dari 30 hari kemudian maka harus dilakukan pengkajian awal.

Pasien dari luar RS dan membawa informasi kesehatan akan menjalani proses pengkajian pasien terdiri dari tiga proses primer sesuai maksud dan tujuan proses IAR

- a) Mengumpulkan informasi dan data terkait keadaan fisik, psikologis, status sosial, dan riwayat kesehatan pasien. → I
- b) Menganalisis data dan informasi, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, pencitraan diagnostik, dan pemantauan fisiologis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien akan layanan kesehatan. → A
- c) Membuat rencana perawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien yg telah teridentifikasi. → R

Bukti hasil dari seluruh pengkajian yang dikerjakan di luar RS ditinjau dan/atau diverifikasi pada saat masuk ranap atau sebelum tindakan di unit rajal.

C. Penetapan risiko nutrisi

Tim asuhan gizi terdiri dari berbagai macam profesi yang mempunyai peran, sbb :

1. Dietisien

- a. Mengkaji hasil skrining gizi dari perawat dan order diet dari dokter
- b. Melakukan pengkajian gizi lanjut pada pasien beresiko malnutrisi, atau kondisi khusus meliputi pengumpulan, analisa, dan interpretasi riwayat gizi atau makanan, biokimia, pemeriksaan fisik/klinis, antropometri, dan riwayat personal pasien
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan diagnosis gizi berdasarkan hasil pengkajian gizi
- d. Menyusun intervensi diet meliputi tujuan dan preskripsi diet yang lebih terperinci serta merencanakan konseling gizi
- e. Melakukan kerjasama dengan dokter terkait diet definitive
- f. Melakukan koordinasi dengan tim asuhan gizi untuk melaksanakan intervensi gizi
- g. Melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak asuhan gizi yang diberikan
- h. Melakukan edukasi gizi
- i. Mencatat dan melaporkan hasil asuhan gizi pada dokter
- j. Melakukan pengkajian ulang jika tujuan tidak tercapai

2. Dokter DPJP

1. Bertanggung jawab dalam aspek gizi pasien yang terkait dengan aspek klinis
2. Menentukan preskripsi diet awal
3. Menetapkan diet definitive dengan ahli gizi
4. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai peran asuhan gizi
5. Merujuk pasien yang membutuhkan konseling gizi
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait masalah gizi

3. Perawat

1. Melakukan skrining gizi pasien awal perawatan
2. Merujuk pasien beresiko malnutrisi ke ahli gizi
3. Melakukan pengukuran antropometri secara berkala

4. Farmasi

1. Mempersiapkan obat dan zat gizi terkait seperti vitamin, mineral, elektrolit dan nutrisi parenteral
2. Menentukan kompatibilitas zat gizi yang diberikan kepada pasien
3. Membantu mengawasi dan mengevaluasi penggunaan obat dan cairan parenteral oleh pasien bersama perawat
4. Berkolaborasi dengan dietisien dalam pemantauan interaksi obat dan makanan
5. Memberikan edukasi ke pasien dan keluarga mengenai interaksi obat dan makanan

5. Tenaga Kesehatan lain misalnya tenaga terapi okupasi dan terapi wicara berkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi pada pasien dengan gangguan menelan yang berat

Asuhan gizi pasien rawat inap adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan gizi yang berkesinambungan dimulai dari perencanaan diet hingga evaluasi rencana diet pasien di ruang rawat inap. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap agar memperoleh gizi yang sesuai dengan kondisi penyakit, dalam upaya mempercepat proses penyembuhan. Mekanisme pelayanan gizi rawat inap tahapan pelayanan diawali dengan skrining oleh perawat ruang IGD dan penetapan order diet awal oleh dokter. Skrining gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko, tidak beresiko malnutrisi atau kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah pasien dengan kelainan metabolic, hemodialisis, anak geriatric, kanker dengan kemoterapi / luka bakar.

Penetapan risiko nutrisional dilakukan oleh staf gizi di RS sebagai berikut :

Pasien ☐ Skrining gizi awal oleh perawat ☐ Pasien malnutrisi & kondisi khusus dikirim ke gizi ☐ Konseling gizi ☐ asuhan gizi lanjutan (untuk pasien bersiko malnutrisi)

Skrining dilakukan pada pasien baru 1x24 jam setelah pasien masuk RS. Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, maka dilakukan assesmen/pengkajian lanjut dengan langkah PAGT. Pasien dengan status gizi baik atau tidak beresiko malnutrisi, dianjurkan dilakukan skrining ulang setelah 1 minggu.

Pencatatan dan laporan kegiatan asuhan gizi merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan dan komunikasi. Terdapat berbagai cara dalam dokumentasi antara lain Subjective Objective Assessment Planning (SOAP) dan Assessment Diagnosis Intervensi Monitoring & Evaluasi (ADIME). Format ADIME merupakan model yang sesuai dengan langkah PAGT.

BAB IV PENUTUP

Panduan pengkajian pasien ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi professional pemberi asuhan untuk melakukan pengkajian terhadap pasien di Rumah Sakit Prima Husada. Dengan adanya panduan pengkajian pasien diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan tenaga medis di Rumah Sakit dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes